

Eksperymenty *behawioralne*

Prognoza → działanie → wynik → wniosek. Naruszenie oczekiwania uczy mocniej niż argumenty — najsilniejszy komponent CBT paniki.

CZAS: 30-60 min na eksperyment Praca na sesji + zadanie domowe

ŹRÓDŁO: Bennett-Levy i wsp. (2004); McManus i wsp. (2012); Craske i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Razem z terapeutą zaplanuj **jeden konkretny eksperyment** testujący Twoje katastroficzne przekonanie. Wypełnij wszystkie pola arkusza *przed* wejściem w sytuację, zostaw miejsce na wynik. Po — wróć z arkuszem na sesję. Powtarzaj z wariacjami 5-10 razy, aż prognoza przestanie się pojawiać.

DLACZEGO TO DZIAŁA

McManus i wsp. (2012) pokazali, że eksperyment behawioralny (ang. *behavioral experiment*) to **najsilniejszy pojedynczy komponent** terapii poznawczo-behawioralnej w panice. Sama restrukturyzacja zmienia przekonania słabiej niż doświadczenie (Bennett-Levy i wsp. 2004): możesz *wiedzieć*, że nie zemdlejesz, a jednocześnie *czuć*, że zemdlejesz — wiedza werbalna i przekonanie emocjonalne żyją w dwóch różnych systemach. Cel: **naruszenie oczekiwania** (ang. *expectancy violation*), nie redukcja lęku.

01 ? Eksperyment ≠ ekspozycja — różnica fundamentalna

Ekspozycja to konfrontacja z sytuacją, by lęk się przyzwyczaił. Eksperyment to *test hipotezy*: masz konkretną prognozę i ją sprawdzasz. Cel ekspozycji = wytrzymać. Cel eksperymentu = **dowiedzieć się**.

	EKSPOZYCJA	EKSPERYMENT
Cel	Wytrzymać, przyzwyczaić się	Sprawdzić konkretną prognozę
Punkt wyjścia	Lista unikanych sytuacji	Konkretnie przekonanie pacjenta
Miernik sukcesu	SUDS spadł poniżej progu	Wiara w prognozę spadła
Powtarzalność	Wiele razy ta sama sytuacja	Wariacja po naruszeniu oczekiwania

02 ☉ Siedem kroków protokołu eksperymentu

1 · Prognoza

Konkretna, mierzalna. „Jeśli pojadę autobusem 3 przystanki bez leku, zemdleję w ciągu 10 min.” Nie „będzie źle”.

2 · Wiara w prognozę

Pewność 0-100% przed eksperymentem. To **pomiar bazowy** do porównania po.

3 · Kryterium wyniku

Po czym poznasz, że prognoza się spełniła? „Stracę przytomność, upadnę.” Obserwowalne kryterium.

4 · Wejście — bez zabezpieczeń

Bez zachowań zabezpieczających, dystrakcji, „awaryjnych planów”. Pełne doświadczenie odczuć.

5 · Monitorowanie

Skala SUDS (0-100) w trakcie. **Nie skracaj**. Zostań do naturalnego końca sytuacji.

6 · Porównanie wynik ↔ prognoza

Co naprawdę się stało? Spełniła się? Częściowo? Wcale? „Zemdlałem/-am? Nie.”

7 · Nowa wiara + wniosek

Pewność prognozy PO (0-100%). Zwykle spada o 20-40% po jednym eksperymentcie. **Wniosek strukturalny** — dlaczego się nie spełniła? Unikaj „bo miałem/-am szczęście” — szukaj wyjaśnienia mechanicznego. „Bo organizm sam reguluje lęk po 20 min.”

Wypełnij pola 1–4 **przed** wejściem w sytuację. Pola 5–7 — bezpośrednio po.

1 · SYTUACJA EKSPERYMENTU

— gdzie, kiedy, co konkretnie

2 · MOJA PROGNOZA

— konkretna, mierzalna, „jeśli X to Y w czasie Z”

3 · WIARA W PROGNOZĘ PRZED (0–100%) + KRYTERIUM WYNIKU

— po czym poznam, że się spełniła?

4 · ZACHOWANIA ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH NIE BĘDĘ UŻYWAŁ/-A

— wymień, by mieć świadomość

5 · WYNIK — CO NAPRAWDĘ SIĘ STAŁO

— fakty obserwowalne, max SUDS w trakcie

6 · WIARA W PROGNOZĘ PO (0–100%)

— porównaj z polem 3

7 · WNIOSEK STRUKTURALNY

— dlaczego prognoza się nie spełniła? Wyjaśnienie mechaniczne, nie „szczęście”

=== CALLOUT ===

Klucz: Craske i wsp. (2014): *błąd przewidywania* (ang. *prediction error*) jest neurobiologicznym mechanizmem zmiany w terapii. Im większa rozbieżność „prognoza vs wynik”, tym silniejsza nauka mózgu. Po 10 eksperymentach przejrzyj zapisy: „Ile razy na 10 prognoza się *naprawdę* spełniła?” Odpowiedź to niemal zawsze zero — to odkrycie robi z eksperymentu nie „ćwiczenie”, lecz **dowód sądowy** w sprawie własnej katastrofy.